

Гіпертермія

Сценарій

Ви лікар з медицини невідкладних станів. В складі бригади екстреної медичної допомоги ви прибуваєте на виклик до чоловіка 43 років. Хворий скаржеться на високу температуру тіла впродовж 3 днів.

Анамнез хвороби: Температура почала наростати в перший день дуже стрімко до 40 °С. Хворий приймав ібупрофен в дозі 400 мг, з початку це допомогло, і температура знижувалася до 37.5°С, але на зараз після прийому зниження температури не відмічається. Тому викликав швидку.

Об'єктивно: Температура тіла 39.8 °С, слабкість, біль у горлі, кашель. При аускультатії в нижніх відділах жорстке дихання.

Необхідно: провести діагностику, встановити попередній діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги при гіпертермії..

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом, встановлення контакту.	<i>Сказати</i> <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i>
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	<i>Сказати</i> <i>Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати</i> <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Анамнез хвороби	<i>Сказати «Що з Вами трапилось»</i> <i>Очікуваний відповідь «Три доби тому в мене піднялася температура до 40°С»</i> <i>Сказати «Чи намагалися ви лікуватися самостійно і чим»</i> <i>Очікуваний відповідь «Так, я приймав ібупрофен в дозі 400 мг, з початку мені допомогло, і температура знижувалася до 37.5°С, але на зараз вже це лікування не допомагає.»</i> <i>Сказати «Чи не було у вас блювоти»</i> <i>Очікуваний відповідь «Ні не було, в мене дуже поганий апетит, я ні хочу ні</i>

		їсти ні пити» <i>Сказати</i> «Чи хворів хтось у вашій родині на ГРВІ за останній час» <i>Очікувана відповідь</i> «Ні»
2.2	Скарги постраждалого	<i>Сказати:</i> «Які у вас скарги?» <i>Очікуваний відповідь:</i> «Висока температура, озноб, біль в горлі, сухий кашель»
2.3	Анамнез життя	<i>Сказати:</i> «Останнім часом ви не були за кордоном? Чи були у вас нещодавно оперативні втручання» <i>Очікувана відповідь</i> «Ні» <i>Сказати</i> «Які захворювання ви перенесли в дитинстві» <i>Очікувана відповідь:</i> «ГРВЗ, дитячі інфекції.»
2.4	Алергійний анамнез	<i>Сказати</i> «Чи були у Вас алергійні прояви раніше і на що?» <i>Очікувана відповідь:</i> «Ніколи не помічав»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	<i>Сказати:</i> Середньої тяжкості. Об'єктивно: слабкість, сухий кашель, температура 39.9°C, АТ 130/90 мм.рт.ст. PS 100 уд. за хв
3.2	Додатковий огляд	<i>Сказати:</i> «1.Звернути увагу на можливу наявність сипу. 2.Звернути увагу на можливі зміни з боку наступних органів і систем: - Суглоби - розпухання і болючість (бурсити, артрити, остеомієліт). - Легені - вислуховуються вологі хрипи (можливі при пневмонії), ослаблення дихання (плеврит). - Серце - шуми при аускультції (можливий бактеріальний ендокардит, міокардит, міксосома передсердя). - Живіт - має значення виявлення при пальпації збільшення органів черевної порожнини, хворобливості, виявлення пухлиноподібних утворень. - Урогенітальна зона: у жінок - патологічні виділення з шийки матки; у

		чоловіків - виділення з уретри. - Пряма кишка - патологічні домішки в калі, додаткові утворення, наявність крові при пальцевому дослідженні. - При неврологічному дослідженні можуть виявлятися ознаки інфекції центральної нервової системи (ЦНС), такі як менінгізм або вогнищеві неврологічні порушення.»
4. Діагностика		
4.1	Встановити попередній діагноз	<i>Сказати : ГРВІ</i>
5.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Надання екстреної допомоги при гіпертермії	<i>Сказати : «Необхідно призначити хворому парацетамол - 500 мг одноразово, Ацетилсаліцилову кислоту - 500 мг одноразово, диклофенак 3,0 в/м»</i> <i>Сказати : «Для симптоматичного лікування гіпертермії необхідно ввести: 2 мл 50% розчину метамізолу натрію з 2 мл дротаверину або 1 мл 3% розчину кеторолаку в/вПри ознаках набряку головного мозку - дексаметазон 8-32 мг (преднізолон 30-60 мг.</i>
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати : Виконувати правила гігієни. Вести здоровий образ життя.</i>
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7.1	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при подальшому загостренні стану тому ми вас повинні доправити до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.</i>

Сценарій